

DERMATOPATÍAS

Dermatitis Atópica

Bibliografía 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Consenso Nacional 2013

Servicio de Dermatología H. Notti 2014

Enfermedad cutánea inflamatoria crónica, multifactorial, caracterizada por una disfunción de la barrera cutánea acompañada de diversas alteraciones en las funciones inmunológicas, afecta a más del 10% de los niños con brotes y remisiones. Comienza habitualmente durante la lactancia, siendo rara su aparición antes de los tres meses de vida.

Factores relevantes en la patogénesis:

1- Alteraciones de la función de barrera del estrato corneo de piel q lleva a:

- Disminución en la producción del factor humectante natural, esto dificulta su adaptación a los cambios del medioambiente así como su renovación y reparación.
- Alteración del pH de la piel.
- Disminución de péptidos antimicrobianos que favorece la adherencia de bacterias.
- Aumento en la permeabilidad a los antígenos exógenos, que permite que los mismos entren en contacto con el sistema inmune y generen respuestas inmunológicas inadecuadas.

2- Anormalidades inmunológicas

3- Desregulación de la vía psico-neuroendocrino-immune

Clasificación de lesiones

- Agudas: pápulas y papulo-vesículas pruriginosas, exudativas, sobre base eritematosa.
- Subagudas: pápulas y/o placas con discreto eritema, descamación y leve engrosamiento.
- Crónicas: pápulas excoriadas, erosionadas o placas liquenificadas, lesiones residuales hipo o hiperpigmentadas.

Fases:

- **Lactante** (3 meses a 3 años de edad)

Las lesiones se localizan en mejillas, cuello, superficies de extensión de los miembros y tronco. Suelen ser más exudativas que en los niños mayores.

- **Infantil** (3 a 10 años de edad)

Tienen su localización característica en las zonas de flexión y pliegues (principalmente cuello, pliegues antecubitales, huecos poplíteos).

Debido a la capacidad de rascado del paciente y al tiempo de evolución de las lesiones pueden evidenciarse excoriaciones y signos de liquenificación.

- **Fase del adolescente**

Afecta particularmente el dorso de manos, párpados y zonas de flexión.



Criterios clínicos para el diagnóstico

Criterios mayores

- Prurito (condición básica)
- Distribución característica
- Antecedentes personales o historia familiar de atopia
- Dermatitis de curso crónico con exacerbaciones y remisiones

Criterios menores

- Xerosis
- Ictiosis/hiperlinearidad palmar/queratosis pilar
- Reactividad inmediata (tipo 1) a test cutáneos
- IgE elevada
- Edad de comienzo precoz
- Tendencia a infecciones cutáneas/defectos de la inmunidad mediada por células
- Dermatitis inespecífica de manos y pies
- Eczema del pezón
- Queilitis
- Blefaritis recurrente
- Pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan
- Queratocono
- Catarata subcapsular anterior
- Oscurecimiento orbitario
- Eritema/palidez centro-facial
- Pitiriasis alba
- Pliegues anteriores del cuello
- Prurito al transpirar
- Intolerancia a la lana y solventes de lípidos
- Acentuación perifolicular
- Intolerancia a alimentos
- Curso influenciado por factores ambientales/ emocionales
- Dermografismo blanco/blanqueo retardado

Para realizar el diagnóstico de DA es necesario que estén presentes tres criterios mayores y al menos tres criterios menores.

Complicaciones

Las infecciones bacterianas son las más comunes y se pueden producir por *Staphylococcus aureus* o *Streptococcus* βhemolítico del grupo A, se manifiestan como formas de impétigo, foliculitis, dermatitis por toxinas y en casos más infrecuentes como infecciones generalizadas y de tejidos blandos.

Diagnósticos diferenciales

- **Dermatitis seborreica:** Se presenta desde los 15 días de vida hasta los 3 a 6 meses. Las escamas son amarillentas y untuosas. Toma cuero cabelludo, zona centofacial y caudal. No es pruriginosa.
- **Dermatitis de contacto irritativa:** Las lesiones, circunscriptas, se vinculan a un agente irritante primario. Ej.: dermatitis por saliva y dermatitis simple del panal.
- **Dermatitis de contacto alérgica:** Es poco frecuente en los niños pequeños. Puede ser por níquel, cromo o tatuajes con henna.
- **Enfermedades eritematoescamosas:** Psoriasis, pitiriasis rosada y pitiriasis rubra pilaris.
- **Ectoparasitosis:** *Sarna eczematizada*. Lesiones papulo-vesiculosas, palmo-plantares. Puede observarse compromiso interdigital y muñecas. Es frecuente observar la enfermedad en otros miembros de la familia.

- **Infecciones micóticas:** *Dermatofitias de piel lampiña*: lesiones eritematoescamosas pruriginosas, anulares, con bordes netos, el crecimiento es centrifugo y la curación central.

- **Infecciones bacterianas**

- **Infecciones virales:**

1. Eczema herpético
2. Exantema asimétrico periflexural de la infancia

Terapéutica

- **Cuidados e hidratación de la piel**

La piel debe ser higienizada en forma eficiente pero suave. El baño tiene como objetivo remover costras y reducir la colonización bacteriana, el baño debe ser templado (27-30 °C), breve (cinco minutos) y con jabón neutro. Para retener la humedad cutánea es aconsejable aplicar los emolientes dentro de los tres minutos de terminado el baño (ejemplo: "Masivol Urea" o "Xerobase" en emulsión de 60 y 100gr respectivamente o crema de 30gr).

Varios estudios demostraron que la utilización de hipoclorito de sodio, en una proporción de media taza en una bañera grande, mejoro el prurito (se propone que podría actuar disminuyendo la carga bacteriana).

Evitar el uso de perfumes, espuma de baño y toallitas perfumadas o con antisépticos.

Vestimenta

Es recomendable el uso de ropa suelta, blanca o de colores claros, suave y de algodón capaz de absorber el sudor. Es importante lavar la ropa antes de usarla por primera vez, preferentemente con jabón blanco u otros detergentes neutros y enjuagarla bien, sin dejar rastros del jabón en las prendas. Evitar el uso de suavizantes y otros productos perfumados de la ropa. Deben evitarse la lana, el nylon y otros géneros sintéticos en contacto con la piel.

Se recomienda asimismo evitar las etiquetas de la ropa contactando con la piel del paciente así como el contacto con broches, y otros adornos que contengan níquel. También se debe minimizar el contacto con fibras sintéticas de la ropa de los adultos, la barba, asientos de plásticos, sabanas ásperas o con alto contenido de nylon.

La sudoración empeora el prurito por lo tanto los pacientes no deben sobreabrigarse. Por otro lado la ropa puede ser una barrera eficaz contra el rascado.

Otros cuidados

Recorte y cepillado de unas y uso de manoplas o guantes.

Contacto con mascotas

Algunos autores sostienen que existe una mayor incidencia de atopia con la exposición temprana al epitelio de los gatos, pero no en aquellos niños en contacto con perros.

Alimentación

1. En un porcentaje importante de pacientes con DA el cuadro clínico no se encuentra relacionado con alergias alimentarias, pero en aquellos pacientes con DA moderada o grave que no responden al tratamiento habitual el médico debe considerar la posibilidad de que un alérgeno alimentario pueda actuar como factor desencadenante del brote.

Corticoides tópicos

Constituyen la primera línea de tratamiento para el brote de DA.

Deben ser elegidos aquellos CT de moderada o baja potencia: hidrocortisona ("Alfacort 1%" crema por 30gr) o mometasona ("Suavicort" crema por 15gr).

Inmunomoduladores tópicos, inhibidores de la calcineurina

El médico puede considerar la prescripción de estas drogas como segunda línea en el tratamiento de los brotes en niños mayores de 2 años.

El tacrolimus se presenta en ungüento en concentraciones del 0,1% y 0,03%.

Antihistamínicos

Algunos pacientes con DA pueden beneficiarse con el uso de antihistamínicos por vía oral. Los de primera generación se utilizan habitualmente por su efecto sedativo como coadyuvantes del tratamiento en fase activa o nocturno (difenhidramina, hidroxicina o Carbinoxamina) y los de 2° o 3° generación si el uso es prolongado (Loratadina, Cetirizina / Desloratadina, Levocetirizina, Fexofenadina, respectivamente)

Fototerapia

Puede ser efectiva y se recomienda en casos graves con lesiones cutáneas extensas y en niños mayores de 12 años.

Recomendaciones Servicio de Dermatología H. Notti

- Baños diarios cortos con agua tibia, usar sustitutos de jabón (syndets) o jabón Dove cremoso.
- Syndets: Isdin, Eucerin, La Roche Posay.
- Secar suavemente, con golpecitos, sin frotar la piel.
- Inmediatamente después del baño, colocar crema humectante sin perfume en todo el cuerpo.
- Aplicar varias veces al día crema humectante sin perfume: Dermaglós (Andrómaco), Nivea creme, Bagovit.
- Usar ropa de algodón clara, evitar contacto de la piel con tejidos sintéticos, nylon, polar o lana.
- Evitar tinturas, cosméticos, desodorantes y perfumes en el momento agudo.
- Evitar contacto excesivo con el agua, jabones, detergentes.
- Baños de avena.
- En eccema de manos, lavar platos siempre con guantes, y colocar guantes de algodón debajo.